Cervicovaginitis: datos que se deben saber de memoria

Fuentes: GPC *Prevención, diagnóstico y tratamiento de vaginitis infecciosa en mujeres en edad reproductiva en el primer nivel de atención* (CIE-10 N76.0) y GPC IMSS-609-19 *Diagnóstico y tratamiento de candidosis vulvovaginal en mujeres mayores de 12 años*. Los criterios de Amsel se agregan como referencia clásica (Amsel, 1983).

1. Las 4 causas y cómo reconocerlas

	Vaginosis bacteriana (VB)	Candidiasis (CVV)	Tricomoniasis (TV)	Chlamydia trachomatis
Agente	Gardnerella, Mobiluncus (anaerobios); pérdida de lactobacilos	*Candida albicans* (85-90 %); si no es albicans: glabrata, krusei, tropicalis	*Trichomonas vaginalis* (protozoario)	Bacteria intracelular
¿ITS?	No	No	**Sí**	**Sí**
Flujo	Fluido, blanco-grisáceo, homogéneo	Blanquecino, grumoso (“requesón”), adherente	Amarillo-verdoso, abundante, **espumoso**	Amarillento
Olor	**Pescado** (fetidez)	**Sin olor**	Fétido	Fétido
Síntomas	Casi ninguno (sin prurito ni dolor)	**Prurito intenso**, eritema, fisuras, disuria, dispareunia	Disuria, dolor pélvico bajo, vulvitis	Con frecuencia asintomática (75 % de mujeres); disuria, dolor hipogástrico
Cérvix	Normal	Normal o edema	**Cérvix en fresa** (puntilleo rosado)	Cervicitis
pH vaginal	**> 4.5**	**Normal (3.5-4.5)**	> 4.5	> 4.5

pH vaginal normal: **3.5 a 4.5**.

2. Diagnóstico

Vaginosis bacteriana

- **Criterios de Amsel** (3 de 4):
    1. Flujo homogéneo, blanco-grisáceo.
    2. pH > 4.5.
    3. Prueba de aminas positiva (olor a pescado con KOH al 10 %).
    4. **Células clave (clue cells)** en el frotis en fresco.
- **Criterios de Hay/Ison** (tinción de Gram):
    - Grado 1: normal, predominan los lactobacilos.
    - Grado 2: intermedio, flora mixta.
    - **Grado 3: VB**, predominan Gardnerella y Mobiluncus con pocos o ningún lactobacilo.
- En una mujer no embarazada con síntomas típicos se puede iniciar tratamiento empírico sin más estudios.

Candidiasis

- Frotis en fresco con **KOH al 10 %**, Gram o citología: se ven levaduras y pseudohifas.
- El **cultivo solo se pide** en recurrencia o en vaginitis complicada.
- **Clasificación:**
    - **No complicada:** esporádica, síntomas leves a moderados, probablemente *C. albicans*, paciente inmunocompetente.
    - **Complicada:** recurrente, severa, no albicans, o paciente con diabetes, inmunosupresión o desnutrición.
    - **Recurrente (CVVR): 4 o más episodios sintomáticos al año**.
- **Factores de riesgo:** diabetes descontrolada, **embarazo**, anticonceptivos orales, obesidad, antibióticos recientes, corticoides, quimioterapia, inmunosupresión.
- **Epidemiología:**
    - 75 % de las mujeres tienen al menos un episodio en la vida.
    - Es la segunda causa de vaginitis, después de la VB.
    - Afecta sobre todo a mujeres de 25 a 44 años.

Tricomoniasis

- Se detecta con Papanicolaou, frotis en fresco (sensibilidad cercana a 60 %), cultivo, pruebas de ácidos nucleicos (NAT) o pruebas rápidas de antígenos.
- Si el frotis o el Papanicolaou reportan *Trichomonas* y no hay cultivo, **se trata igual**.

Chlamydia

- Se diagnostica con NAAT, incluso en muestra de **orina**. También sirven cultivo y otras pruebas.
- Si hay sospecha de ITS, se pide además estudio de gonorrea y sífilis.

3. Tratamiento

Vaginosis bacteriana

	Esquema
Elección	**Metronidazol 500 mg VO cada 12 h por 7 días**, o **2 g VO dosis única**, o metronidazol vaginal por 5 días
Alternos	Clindamicina crema vaginal 2 % una vez al día por 7 días; clindamicina 300 mg VO cada 12 h por 7 días; tinidazol
Embarazo	Se trata siempre: metronidazol. Si no se trata, aumenta el riesgo de aborto, parto prematuro, RPM y endometritis. Con antecedente de parto pretérmino o RPM: metronidazol oral
Pareja	No se trata de rutina
DIU	Se sugiere cambiar el método anticonceptivo
Lactancia	**No usar clindamicina**

Tratar VB cuando hay síntomas o cuando la paciente asintomática va a cirugía, va a ponerse un DIU o desea tratarse.

Candidiasis no complicada

	Esquema
Oral (primera línea)	**Fluconazol 150 mg dosis única**, o itraconazol 200 mg cada 12 h por 1 día
Tópico	**Miconazol crema 2 %**, una aplicación diaria por 7 días; nistatina vaginal 100 000 U diaria por 14 días
Embarazo y lactancia	**Azoles orales contraindicados**: se usa tratamiento tópico
Embarazada asintomática	No se trata
Pareja	No se trata
Abstinencia	No es necesaria

Los azoles tópicos pueden irritar, y las cremas **dañan los condones y los diafragmas de látex**.

Candidiasis recurrente (≥ 4 episodios al año)

- **Inducción:**
  - Fluconazol 150 mg cada 72 h × 3 dosis, o
  - itraconazol 200 mg cada 12 h por 1 día, o
  - miconazol vaginal por 14 días, o
  - ketoconazol 100 mg al día por 14 días.
- **Mantenimiento por 6 meses**, a elegir:
  - fluconazol 100-150 mg **una vez por semana**;
  - ketoconazol 100 mg al día;
  - itraconazol 50-100 mg al día.
- Ninguno de estos esquemas orales se usa en el embarazo ni en la lactancia.
- Si persisten los síntomas, se envía a segundo nivel.

Tricomoniasis

	Esquema
Elección	**Metronidazol 500 mg VO cada 12 h por 7 días**, o **2 g VO dosis única**
Alterno	Tinidazol 2 g dosis única
Embarazo	Metronidazol 2 g dosis única
Lactancia	Suspender la lactancia durante 12 a 24 h tras el medicamento
Pareja	**Se trata siempre, de forma simultánea**

	Esquema
Abstinencia	Hasta que ella y la pareja terminen el tratamiento, incluido el sexo oral
Seguimiento	Reevaluar en un máximo de **3 meses**; la reinfección es de 17 %
Alcohol	**Evitar** (efecto antabuse)

Si el tratamiento falla, hay que revisar:

- el apego al tratamiento y si hubo vómito;
- una posible reinfección;
- si la pareja se trató.

Chlamydia

	Esquema
Primera línea	**Azitromicina 1 g VO dosis única**, o **doxiciclina 100 mg VO cada 12 h por 7 días**
Alternos	Eritromicina 500 mg cada 6 h por 7 días; levofloxacino 500 mg al día por 7 días; ofloxacino 300 mg cada 12 h por 7 días
Embarazo	**No usar doxiciclina ni levofloxacino**; en su lugar azitromicina, eritromicina, amoxicilina o clindamicina
Pareja	**Se trata**

4. Resumen rápido para el examen

Dato clave	Respuesta
Causa más frecuente de vaginitis	**Vaginosis bacteriana**
Flujo con olor a pescado, sin prurito	VB
Flujo en “requesón”, prurito, pH normal	Candidiasis
Flujo espumoso, cérvix en fresa	Tricomoniasis
Célula clave	VB
Tratamiento de VB y de tricomoniasis	Metronidazol
Tratamiento de candidiasis	Fluconazol 150 mg dosis única
¿Se trata a la pareja?	**Solo en tricomoniasis y Chlamydia**
ITS	Tricomoniasis y Chlamydia
Asintomática en embarazo	Se trata VB; **no** se trata candidiasis
Vaginitis recurrente por Candida	≥ 4 episodios al año

5. Referencia a segundo nivel

- Mujeres con VIH.
- Sin respuesta al tratamiento.
- Candidiasis por especies distintas de *C. albicans* que no responden al tratamiento.

6. Complicaciones e incapacidad

- Las infecciones genitales aumentan el riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad, resultados adversos del embarazo e infección por VIH.
- En el embarazo se asocian con ruptura prematura de membranas.
- La candidiasis severa puede justificar una incapacidad de 1 a 3 días.